Antibiothérapie sous-cutanée

Recommandations de bonnes pratiques cliniques SPILF/SFGG 2025

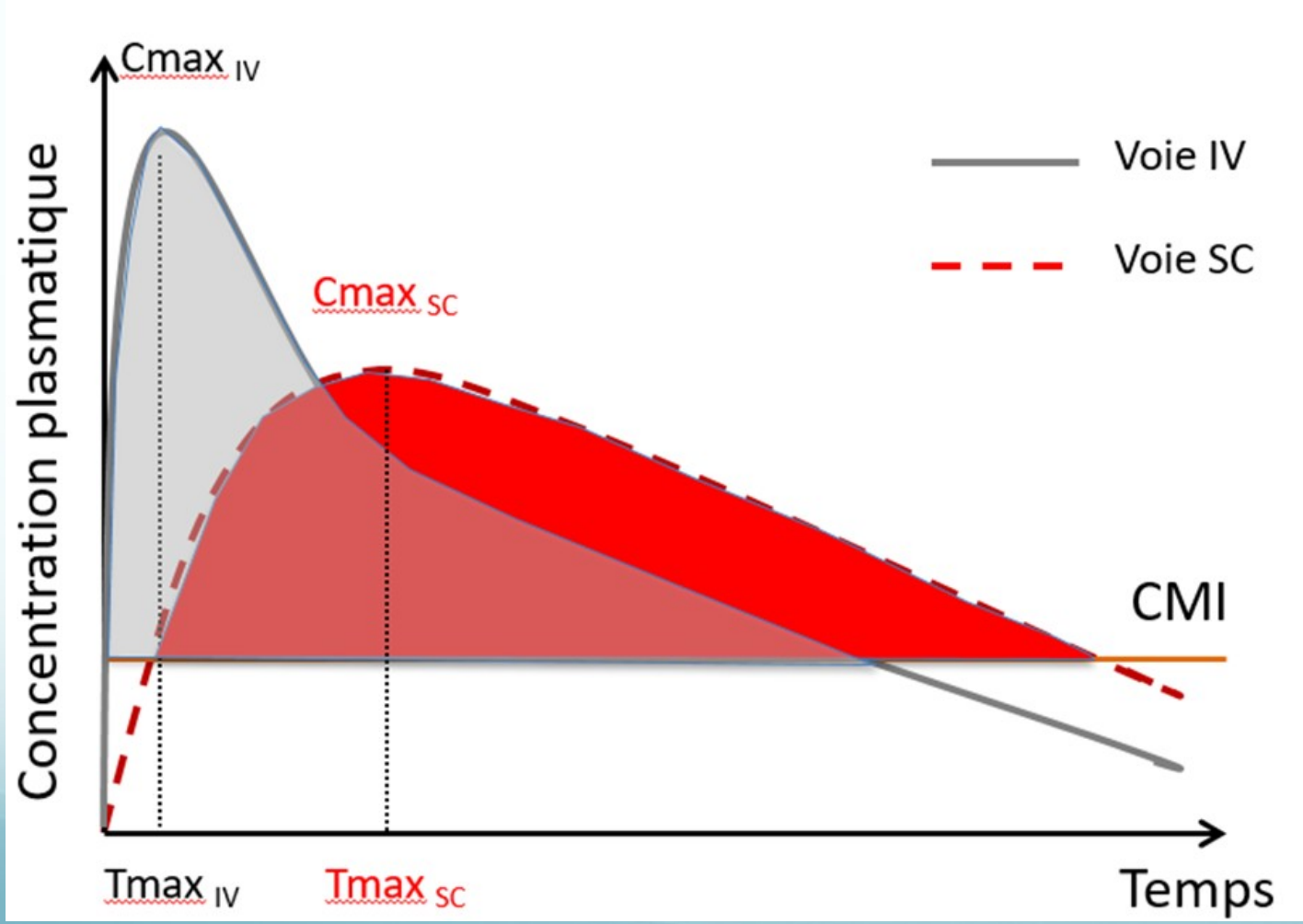
Jeu de diapositives réalisé par le comité des référentiels de la SPILF
le 11/03/2026

Introduction/contexte

- **Objectifs de ces recommandations :**

  - Préciser le rationnel PK/PD
  - Définir les indications et non indications
  - Statuer sur les antibiotiques utilisables par voie SC
  - Etablir les modalités d’administration et de surveillance
  - Rappeler les aspects réglementaires (prescription hors AMM)

Rationnel pharmacocinétique



Comparaison SC vs IV

Biodisponibilité ~ 100%

Cmax ↘ - Tmax ↗

Aire sous la courbe →

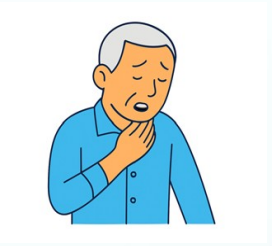
T > CMI →

Ne pas utiliser la voie SC pour les antibiotiques concentration dépendants

Indications

- La **voie orale** est toujours **à privilégier (**dans la mesure du possible).
- La voie SC est une **alternative pragmatique** lorsque les voies orale, IV et/ou IM sont impossibles ou inappropriées :
  - Capital veineux précaire
  - Agitation/confusion
  - Soins de conforts
  - Troubles de la déglutition
  - Anticoagulation efficace (IM contre-indiquée)
  - Facilitation du retour à domicile/soins ambulatoires
  - Nécessité d’une antibiothérapie parentérale prolongée (suppressive notamment)





Contre-indications

- **Infection grave** (absorption retardée et/ou moindre favorisée par la vasoconstriction)
- **Dermatose étendue ou lymphoedème important** aux sites de pose de cathéter SC

Antibiotiques utilisables par voie SC

Grade	Molécules	Commentaire
Grade A	**Ceftriaxone**	*Données pharmacocinétiques et cliniques de bonne qualité; aucune réserve en terme d'efficacité et de tolérance.*
Grade B	**Benzathine pénicilline, Céfazoline, Ertapénème, Méropénème, Pipéracilline-Tazobactam, Témocilline**	*Données pharmacocinétiques de bonne qualité, données cliniques limitées; peu de réserves en terme d'efficacité et de tolérance.*
Grade C	**Téicoplanine** ***Sur avis spécialisé:*** **Amoxicilline, Amoxicilline-acide clavulanique, Céfépime, Ceftazidime, Daptomycine**	. *Teicoplanine: données pharmacocinétiques de bonne qualité, données cliniques limitées; pas de réserve en terme d'efficacité, tolérance variable.* . *Avis spécialisé requis pour les autres antibiotiques car données pharmacocinétiques et cliniques limitées; peu de réserves en terme d'efficacité et de tolérance.*
EXCLUS	**Aminosides**	*Risques de nécrose cutanée et/ou d'inefficacité*

La référence: la ceftriaxone

100 %

Bio-disponibilité

Excellente absorption par voie SC, comparable à la voie IV.



Administration

Alternative de choix si les voies IV et IM sont impossibles.

Possibilité de débuter le traitement d’emblée en SC.



Tolérance

Effets indésirables locaux (douleur, induration) modérés, transitoires et réversibles chez 20% des patients.

Note : Usage "Hors AMM" mais encadré par la recommandation.

Cas particuliers

Teicoplanine

- **Dose de charge IV impérative :** Pendant 48h avant le relais SC.
- **Surveillance :** Dosages plasmatiques résiduels indispensables pour ajuster la posologie.
- Risque d'effets indésirables locaux plus élevé qu'avec les bêta-lactamines.

Benzathine Pénicilline G

- Alternative à la voie IM (souvent douloureuse).
- **Technique :** Injection SC directe.
- **Pré-requis :** Anesthésie locale préalable (lidocaïne SC) au site d'injection pour limiter la douleur.

Modalités pratiques de perfusion



Dilution

Utiliser les **mêmes dilutions et posologies** que pour la voie intraveineuse (50cc de NaCl 0.9% ou G5%).



Durée & Méthode

Perfusion gravitaire recommandée.

Durée : **20 à 30 minutes** (objectifs: réduire la douleur et favoriser l'absorption).



À Éviter

Pas d'injection directe en bolus (hors benzathine pénicilline), sauf si absence d’alternative et rapport bénéfice/risque jugé favorable

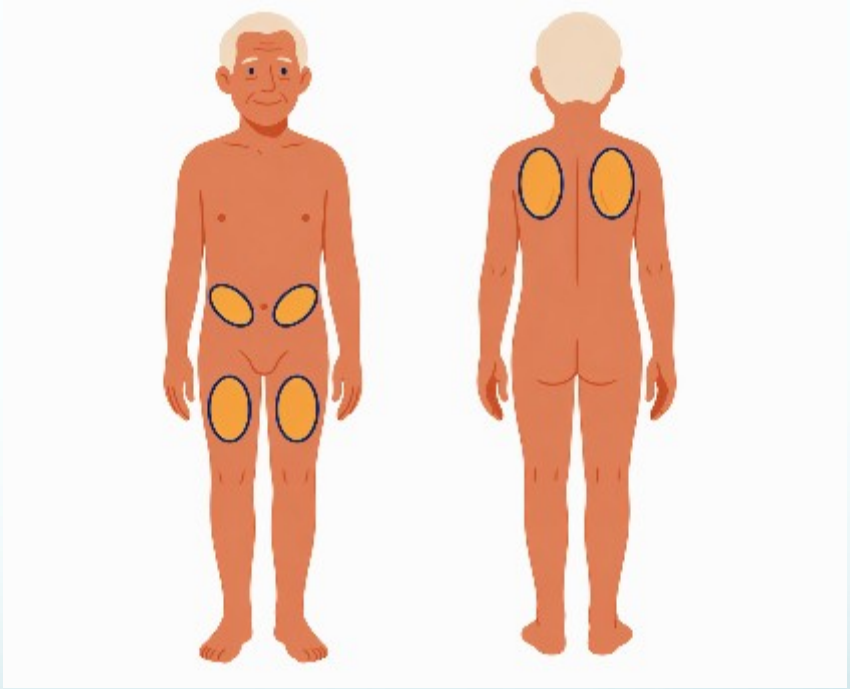
Sites d’administration

Zones Privilégiées

Utiliser les sites riches en tissu adipeux sous-cutané :

- Face externe des **cuisses**.
- Paroi **abdominale** (en évitant la zone péri-ombilicale).
- Région de la **scapula** (omoplate).

Rotation des sites : Indispensable pour prévenir lipodystrophies et indurations.



Surveillance

- **Surveillance quotidienne** du point de ponction (rougeur, chaleur, douleur, nécrose).
- **Arrêt immédiat** si réaction locale importante.
- **Durée cathéter :** Maximum **5 jours** sur le même site.
- **Anticoagulants :** Vigilance accrue (risque d'hématome), mais pas de contre-indication formelle.
- **Pharmacovigilance :** Déclaration à faire obligatoirement en cas d’effet indésirable grave.

Cadre réglementaire

Prescription & Traçabilité

L'administration SC d'antibiotiques est une pratique "Hors AMM". Elle engage la responsabilité du prescripteur.

Obligations du Médecin :

- **Information du patient** (ou de sa personne de confiance) sur le caractère hors AMM et les risques/bénéfices
- **Accord du patient** (ou de sa personne de confiance) tracé dans le dossier médical.
- **Protocole dédié** à rédiger en établissement de santé.
- **Mention sur l'ordonnance** pour les prescriptions ambulatoires **:**

Modalité d'administration hors AMM, validée après information et accord du patient de la balance bénéfice/risque favorable, en accord avec les recommandations de bonnes pratiques cliniques SPILF/SFGG 2025 de l'antibiothérapie sous-cutanée, et avec la lettre aux professionnels de santé de l'ANSM de novembre 2019

Modèles d’ordonnances

Pour la pharmacie

CEFTRIAXONE 1 g poudre pour sol inj intraveineuse

A administrer par voie sous-cutanée (sic) (1g par jour dilué dans 50 ml de chlorure de sodium 0.9% à administrer sur une durée de 30 à 60 minutes) pendant XX jours

Modalité d'administration hors AMM, validée après information et accord du patient de la balance bénéfice/risque favorable, en accord avec les recommandations de bonnes pratiques cliniques SPILF/SFGG 2025 de l'antibiothérapie sous-cutanée, et avec la lettre aux professionnels de santé de l'ANSM de novembre 2019

QSP: XX j

Cachet et signature du prescripteur

Pour l’IDE

Merci de faire pratiquer par IDE à domicile, dimanches et jours fériés inclus, à compter du ..... les soins suivants :

- Pose d’un cathéter sous-cutané sur les flancs ou les cuisses ;

- Préparation de perfusion de CEFTRIAXONE 1g (1g de CEFTRIAXONE à diluer dans 50 ml de sérum physiologique et à passer par voie sous-cutanée (sic) par gravité sur une durée de 30 à 60 minutes) ;

- Branchement de cette perfusion ;

- Fréquence et/ou horaire de passage : (si nécessité médicale, apposer la mention « nuit » ou « intervalle de 12 heures » si 2 injections/jour) ;

- Surveillance journalière du site de pose du cathéter ;

- Changement du cathéter SC au maximum après 5 jours d'utilisation ;

- Pendant X jours

Modalité d'administration hors AMM, validée après information et accord du patient de la balance bénéfice/risque favorable, en accord avec les recommandations de bonnes pratiques cliniques SPILF/SFGG 2025 de l'antibiothérapie sous-cutanée, et avec la lettre aux professionnels de santé de l'ANSM de novembre 2019

Cachet et signature du prescripteur